Atendimento de Enfermagem à Pessoa com TEA

Cartilha de orientação para a equipe de enfermagem
da Unidade Básica de Saúde: antes, durante e depois

Acolhimento · Triagem · Vacina · Procedimentos

UBS · Enfermagem



Para enfermeiros, técnicos, ACS e recepção

Material educativo · Autoria: Dr. Patrício Almeida
Mesma série da cartilha odontológica

Por que esta cartilha

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a porta de entrada do SUS, e a **equipe de enfermagem** é quem mais tem contato com a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA): no acolhimento, na triagem, na sala de vacina, nos curativos, na coleta de exames, na puericultura e na visita domiciliar. Barulho, espera, toque sem aviso e mudanças de rotina podem gerar sobrecarga, recusa ou crise. **Não é birra: é um pedido de previsibilidade.**

Com preparo simples e sempre o mesmo jeito de atender, o cuidado acontece com menos sofrimento para todos. Esta cartilha segue a mesma lógica da cartilha odontológica da série: **antes, durante e depois**, mais um guia por procedimento e uma história social para a criança.



Quem usa

Enfermeiros e técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde (ACS) e recepção da UBS. Pode ficar na sala de triagem, na sala de vacina e no acolhimento. A página 7 (história da vacina) pode ser impressa e entregue à família.

ANTES
Identificar no cadastro, conhecer o perfil sensorial, preparar o ambiente e combinar os sinais.

DURANTE
Acolher com calma, Falar–Mostrar–Fazer, um procedimento de cada vez, respeitar o PARE.

DEPOIS
Elogiar, recompensar, registrar o que funcionou e planejar o próximo atendimento.

O que você encontra aqui

3 · Antes: cadastro, perfil sensorial, agenda e ambiente

4 · Durante: acolhimento, triagem e comunicação

5 · Procedimentos: vacina, curativo, coleta, medicação

6 · Depois: recompensa, registro, retorno e visita domiciliar

7 · História social “Minha vacina na UBS” (para a família)

8 · Informativo e ficha do perfil sensorial

Regra de ouro: previsibilidade, uma coisa de cada vez e nunca forçar. Um atendimento em que a pessoa só conheceu a sala e saiu tranquila **deu certo**: o próximo será mais fácil.

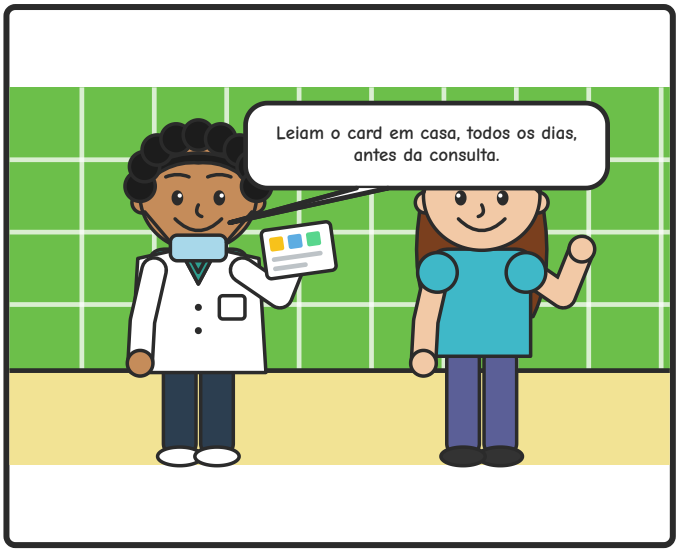
Pessoas com TEA têm direito a atendimento prioritário e a acompanhante (Lei 12.764/2012, Lei 13.146/2015 e Lei 13.977/2020, da Carteira de Identificação da Pessoa com TEA). Esta cartilha é educativa e não substitui protocolos da unidade nem a avaliação clínica individual.

1 ANTES do atendimento

Conhecer a pessoa e preparar a unidade



1. O ACS e a enfermagem conhecem a família na visita domiciliar: como a pessoa se comunica, o que a acalma, o que a incomoda.



2. A família recebe a história social e fotos da UBS para ler em casa antes do dia. Chegar sabendo o que vai acontecer muda tudo.

Checklist do ANTES

- **Sinalize no cadastro** (e-SUS/prontuário) que a pessoa tem TEA e anote o perfil sensorial (ficha da página 8). Toda a equipe deve ver o alerta antes de chamar.
- **Entrevista com a família ou cuidador** (na visita do ACS, por telefone ou na recepção): comunicação, sensibilidades, gatilhos, o que acalma, experiências anteriores com injeção e sangue, medicações.
- **Agende horário de menor movimento** (primeiro do turno) e garanta a **prioridade** no atendimento: espera curta, sem fila.
- **Envie fotos ou vídeo curto** da UBS, da sala de vacina e da equipe (sem máscara) e entregue a história social da página 7.
- **Prepare um espaço calmo** para a espera: sem TV alta, luz suave, poucas pessoas. Separe fones ou abafadores, brinquedo de distração, adesivos de recompensa.
- **Agrupe procedimentos** e combine a ordem com a família: o mais difícil (vacina, coleta) primeiro ou por último? Em geral, **primeiro e rápido**, para não aumentar a ansiedade.
- **Combine os sinais:** mão levantada = PARE; polegar = tudo bem. Combine também o “tempo combinado”: “conto até dez e acabou”.

Mesma pessoa, mesma sala: sempre que possível, a mesma profissional atende nas próximas visitas. A repetição transforma a UBS em um lugar seguro.

2 DURANTE: acolhimento e triagem

Acolher, apresentar e medir sem susto



3. A recepção já sabe: chama pelo nome, sem gritar, e leva a família para o espaço calmo. Nada de esperar na fila.



4. Na triagem, Falar–Mostrar–Fazer: a enfermeira mostra a braçadeira, deixa tocar, aperta primeiro no ursinho e só então no braço.

Como proceder

Chame pelo nome, com voz calma, na altura dos olhos. Não exija contato visual nem "dá um oi". Avise antes de tocar: "vou tocar no seu braço".

Acompanhante sempre junto, onde a pessoa possa vê-lo. Pergunte a ele como ela diz "sim", "não" e "dor". Uma voz de cada vez na sala.

Falar–Mostrar–Fazer em tudo: termômetro, braçadeira, oxímetro, balança, estetoscópio. Mostre, deixe tocar, use no brinquedo ou no acompanhante, depois na pessoa.

Linguagem literal e curta: "vai apertar como um abraço", "vai ficar gelado", em vez de "não vai doer" ou "é rapidinho". Uma instrução por vez, na mesma ordem.

Dê previsibilidade: conte em voz alta ("até dez e solta"), mostre a sequência visual ou a história social, avise cada etapa antes e quando terminar.

Reduza estímulos: fones ou abafadores, luz suave, sem conversas paralelas, sem aparelhos ligados de surpresa. Balança e aferição podem ser feitas sentada, no colo ou em pé.

Sinais de sobrecarga (tapar ouvidos, balançar, gritar, morder, tentar sair, "desligar"): pare, reduza estímulos, ofereça o objeto de conforto e dê tempo. Se não der, remarque sem culpa.

Medidas flexíveis: se a pessoa não tolera a braçadeira hoje, registre, oriente a família e tente na próxima visita. Pressão, peso e temperatura podem ser aferidos em etapas.

3 DURANTE: procedimentos

Vacina, curativo, coleta de sangue e medicação



Vacinação

- **Prepare tudo antes** de chamar: seringa pronta, fora do campo de visão até a hora.
- Posição de conforto: **no colo ou abraçado** pelo acompanhante, de frente para ele. Nunca segurar à força.
- **Distração ativa:** brinquedo, vídeo curto, bolha de sabão, contar junto. Óculos escuros e fones ajudam.
- Se forem várias doses, **combine a ordem** e faça sem pausas longas, ou divida em dois dias se a família preferir.
- Adesivo ou carimbo no fim, sempre.

Diga: "Vai ser uma picadinha rápida, como um beliscão. Olha para o ursinho. Um, dois, três... pronto!"



Curativos e pequenos procedimentos

- Mostre o material; deixe **tocar na gaze e no esparadrapo** antes.
- Avise cada sensação: "vai ficar gelado", "vai puxar um pouquinho".
- **Deixe escolher** o que for possível: a cor do curativo, o braço, sentado ou deitado.
- Retirada de pontos e troca de curativo: mesma sequência, mesma profissional.

Diga: "Primeiro eu limpo, fica gelado. Depois coloco o curativo. Você escolhe a cor."



Coleta de sangue e medicação injetável

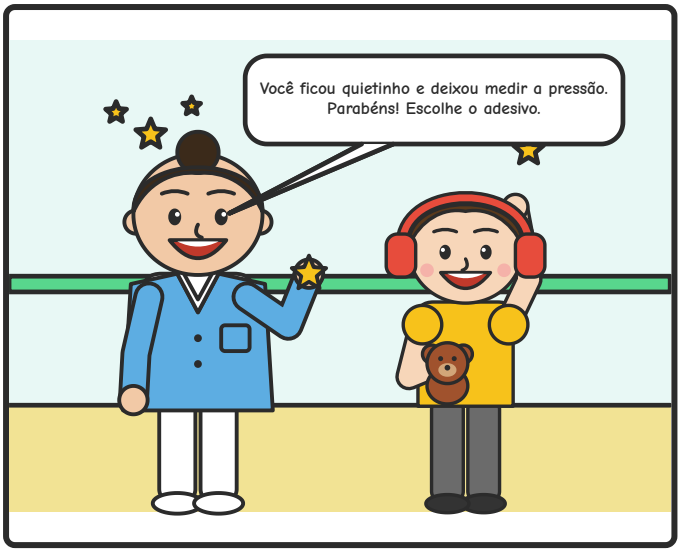
- Agende como **primeira coleta do dia**; jejum longo piora a tolerância.
- Garrote: **mostre e aperte primeiro no acompanhante**; conte o tempo em voz alta.
- Profissional mais experiente para **uma punção só**. Se a veia não vier, pare e remarque.
- Medicação oral: pergunte sabor e textura que a pessoa aceita; use seringa dosadora ou copinho conhecido.

Diga: "Vou amarrar esta fitinha no braço. Aperta um pouco. Até dez e acabou."

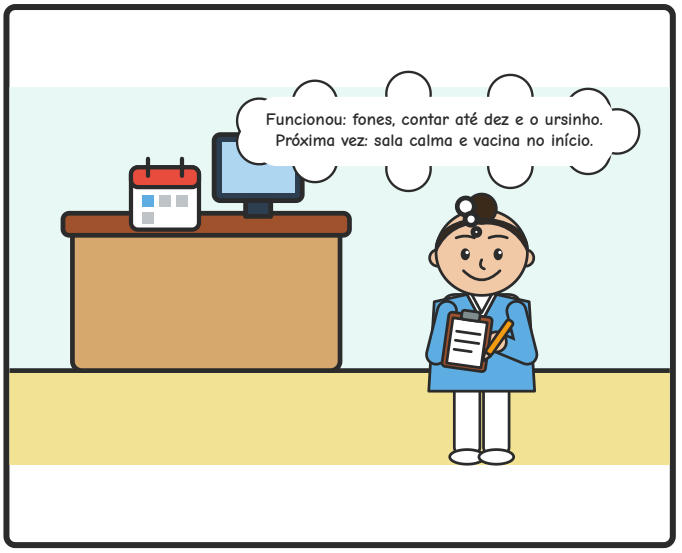
Nunca forçar nem segurar. Contenção só com indicação, consentimento da família e protocolo da unidade. Em caso de recusa: encerrar de forma positiva, registrar e reagendar.

4 DEPOIS do atendimento

Recompensar, registrar e dar continuidade



5. Terminou? Elogio específico e adesivo, mesmo que só tenha medido a temperatura. O atendimento sempre acaba bem.



6. A enfermeira registra o que funcionou. Na próxima vez, a equipe repete a sequência e tenta mais um passo.

Como proceder depois

Encerre de forma positiva: diga o que a pessoa fez de bom, entregue o adesivo e avise o que acontece na próxima vez.

Registre no prontuário o que funcionou e o que não funcionou (fones? colo? contagem? sala calma?) e o degrau alcançado. Compartilhe com toda a equipe da UBS.

Marque o retorno antes de a família sair, no mesmo horário e com a mesma profissional. Vacinas atrasadas: monte um plano de recuperação em poucas visitas.

Oriente a família sobre o que praticar em casa: brincar de “medir a pressão” e de “vacina” com o brinquedo, ler a história social, treinar o sinal de PARE.

Visita domiciliar e rede: o ACS acompanha; articule com o NASF/eMulti, CAPS infantil, APAE, escola e odontologia da unidade. Verifique a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA e os direitos da família.

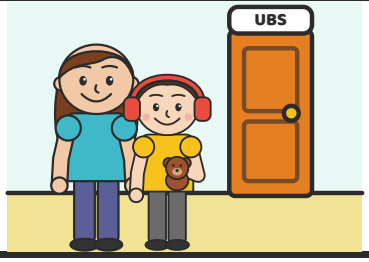
Promoção de saúde: rotina visual de higiene, sono e alimentação; encaminhe para a cartilha odontológica da série e para a consulta de enfermagem programada.

Consulta de enfermagem programada: uma visita só para conhecer a sala, sentar na maca e ganhar o adesivo, sem procedimento, é o melhor investimento para as próximas.

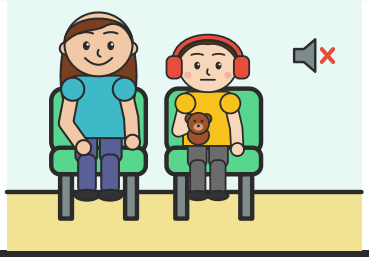
Minha vacina na UBS

Para a família ler em casa com a criança, todos os dias, antes da consulta.

Recorte e entregue



1 Hoje eu vou ao posto de saúde. Chego com quem cuida de mim e levo meu brinquedo e meus fones.



2 Espero um pouquinho em um lugar calmo. Posso ficar com meus fones.



3 Chamam o meu nome. A enfermeira diz "oi" e me mostra a sala e as coisas dela. Posso tocar.



4 Ela mede minha temperatura e aperta meu braço com a braçadeira, como um abraço. Conta até dez e solta.



5 Sento no colo. Olho para o ursinho. A vacina é uma picadinha rápida: 1, 2, 3... pronto! Se eu quiser parar, levanto a mão.



6 Deu tudo certo! Ganho um adesivo e digo tchau. Volto outro dia e já sei como é.

Mão levantada

PARE. A enfermeira para na hora.

Pausa

Quero descansar um pouco.

Polegar

Tudo bem, pode continuar.

Para quem cuida

- Leia esta história todos os dias na semana da consulta, apontando cada quadro.
- Leve brinquedo, fones ou abafadores e óculos escuros, se ele usa.
- No dia, fique de frente para ele, com voz calma. Deixe a enfermeira conduzir.
- Brinque de "vacina" e de "medir a pressão" com o brinquedo dele.
- Pratique o sinal de PARE e o polegar de "tudo bem".
- Comemore o que ele conseguiu, por menor que pareça, e marque a próxima visita.

Minha consulta: dia _____ às _____ na UBS _____ com _____

História social ilustrada · Autoria: Dr. Patrício Almeida · Pode ser reproduzida gratuitamente para fins educativos.

Informativo e ficha

O TEA na UBS, em poucas palavras

O autismo é um espectro: cada pessoa é única. Quatro pontos mudam o atendimento: sensorial (sons, luzes, cheiros e toques sentidos de forma intensa), comunicação (entendimento literal; pode não falar, mas entende), previsibilidade (mudanças geram ansiedade; mesma equipe, mesma sala, mesma sequência) e interesses intensos (use o tema favorito para explicar e recompensar). A pessoa com TEA tem direito a prioridade e acompanhante em todo o SUS.

O que dizer e o que evitar

Evite	Prefira
"Não vai doer nada, é rapidinho."	"Vai ser uma picadinha, como um beliscão. Conto até três."
Chamar gritando pelo corredor; fila na porta.	Chamar pelo nome, perto, com voz calma; espera em lugar quieto.
Segurar à força "para acabar logo".	Colo do acompanhante, distração, contagem; se não der, remarcar.
Ligar aparelhos ou tocar de surpresa.	"Vou tocar no seu braço agora. Primeiro no ursinho, depois em você."
Vários profissionais falando ao mesmo tempo.	Uma voz só, sempre a mesma pessoa.

Ficha rápida do perfil sensorial (anexar ao prontuário)

Nome: _____ Idade: _____ Responsável: _____ Tel.: _____

Comunicação: ☐ Fala ☐ Figuras ☐ Gestos Como diz "sim/não/dor": _____

Incomoda: ☐ Sons ☐ Luz ☐ Cheiros ☐ Toque ☐ Garrote/braçadeira ☐ Deitar Outros: _____

Acalma: _____ Brinde que funciona: _____

Já funcionou: ☐ Fones ☐ Óculos ☐ Colo ☐ Contagem ☐ História lida ☐ Sala calma Sinal de PARE: _____

Última visita (data / o que foi feito / próximo passo):

_____

Base das recomendações: Falar–Mostrar–Fazer, dessensibilização sistemática, histórias sociais, apoio visual e reforço positivo; Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com TEA (Ministério da Saúde) e Política Nacional de Atenção Básica. Autoria: Dr. Patrício Almeida. Material educativo; não substitui os protocolos da unidade nem a avaliação clínica individual.